

Désorientation sur le lieu ou le moment

La personne ne sait plus où elle se trouve ou quel moment de la journée c'est.

■ NE PAS CONFONDRE AVEC UNE CONFUSION AIGUË (URGENCE MÉDICALE)

La désorientation décrite ici est un symptôme CHRONIQUE et connu des troubles neurocognitifs.

La CONFUSION (syndrome confusionnel / delirium) est différente : apparition BRUTALE et récente, souvent avec fluctuation dans la journée.

Elle signale généralement une cause somatique à traiter en urgence : infection, déshydratation, constipation/occlusion, effet d'un médicament (iatrogénie), douleur non exprimée.

Tout changement brutal et récent de l'orientation ou de la vigilance doit être transmis IMMÉDIATEMENT au professionnel compétent, et non traité comme une simple désorientation.

Comprendre

- Comparer avec le fonctionnement HABITUEL de la personne : cette désorientation est-elle déjà connue ?
- Décrire précisément ce qui est observé plutôt que de conclure directement.

Réorienter sans mettre en échec

- Donner un repère simple et concret plutôt que de corriger ou tester la mémoire.
- Relier l'information à l'action qui va suivre immédiatement.

Environnement

- Installer des repères visuels simples (horloge, calendrier, pictogrammes) sans surcharger l'espace.
- S'appuyer sur les routines pour donner des repères temporels concrets.

Transitions

- Réduire les changements de repères lors des transitions (lieu, personnel, horaires).
- Préparer les changements nécessaires avec un délai adapté.

À NE JAMAIS FAIRE

- ✗ Dire « vous devriez le savoir ».
- ✗ Multiplier les questions pour tester l'orientation.
- ✗ Confondre cette désorientation avec une confusion aiguë (voir alerte ci-dessus).

Apézeo — quelques pistes à adapter selon la personne, pas une marche à suivre. Consultez l'application pour le déroulement détaillé de chaque piste.